

## PERICORONARITE — LIMPAR + ANALGESIA + ATB SE SISTÊMICO

### PERICORONARITE — CONCEITOS

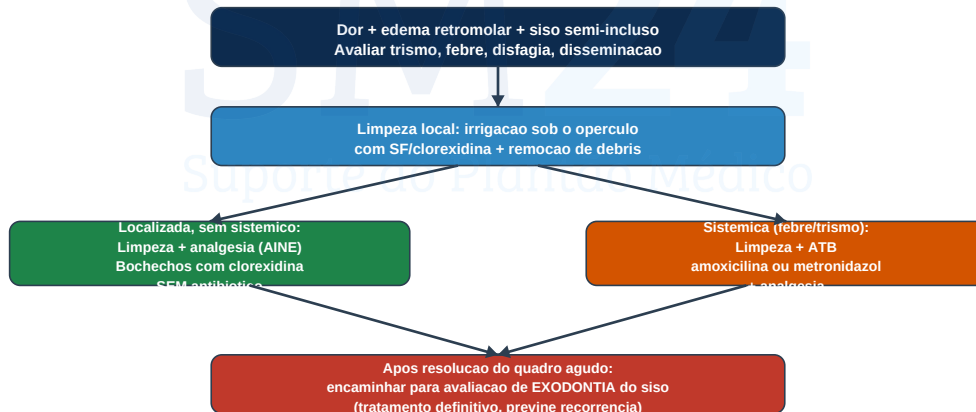
| Aspecto            | Detalhe                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definição          | Inflamação dos tecidos moles (opérculo gengival) ao redor de um dente parcialmente irrompido |
| Dente mais afetado | Terceiro molar inferior (siso) semi-incluso                                                  |
| Mecanismo          | Acúmulo de placa e restos alimentares sob o opérculo → inflamação/infecção                   |
| Faixa etária       | Adultos jovens (17-25 anos) — período de erupção dos sisos                                   |
| Fatores            | Trauma do dente antagonista sobre o opérculo, higiene difícil da região                      |
| Flora              | Mista — anaeróbios e estreptococos da cavidade oral                                          |

### CLASSIFICAÇÃO E CLÍNICA

| Forma                         | Clínica                                                          | Conduta                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aguda localizada              | Dor, edema do opérculo, mau gosto, sem sintomas sistêmicos       | Limpeza local + analgesia      |
| Aguda com sintomas sistêmicos | Dor + trismo + febre + linfadenopatia + disfagia leve            | Limpeza + ATB + analgesia      |
| Crônica                       | Desconforto intermitente, halitose, episódios recorrentes        | Avaliar exodontia do siso      |
| Complicada                    | Disseminação fascial, trismo grave, comprometimento de via aérea | Internação + ATB IV + drenagem |

### MANEJO DA PERICORONARITE

#### PERICORONARITE — LIMPEZA LOCAL PRIMEIRO



## SINAIS DE ALARME — DISSEMINAÇÃO

### QUANDO ENCAMINHAR COM URGÊNCIA

- Trismo importante (incapacidade de abrir a boca) — comprometimento do espaço mastigatório
- Disfagia, odinofagia, voz abafada — comprometimento de espaços profundos do pescoço
- Edema cervical, abaulamento de assoalho de boca — risco de angina de Ludwig
- Febre alta, toxemia, taquicardia — infecção sistêmica/seps
- Comprometimento de via aérea — emergência (internação + via aérea + drenagem)
- Conduta: internação, ATB IV (ampicilina-sulbactam), avaliação buco-maxilo + TC se necessário

## TRATAMENTO LOCAL E MEDICAMENTOSO

### Tratamento Local

- Irrigação sob o opérculo com soro fisiológico ou clorexidina 0,12%
- Remoção de debris alimentares e placa acumulada
- Bochechos com clorexidina 0,12% 2x/dia
- Ajuste oclusal/desgaste do dente antagonista se traumatiza o opérculo
- Operculectomia: remoção do opérculo em casos selecionados
- Higiene oral cuidadosa na região

### Medicação

- Analgesia: ibuprofeno 600 mg 8/8h (AINE de escolha na dor odontológica)
- ATB apenas se sintomas sistêmicos: amoxicilina 500 mg 8/8h por 7 dias
- Alternativa: metronidazol 400 mg 8/8h (boa cobertura de anaeróbios)
- Alergia à penicilina: clindamicina 300 mg 6/6h
- ATB não substitui a limpeza local nem a exodontia
- Tratamento definitivo: exodontia do siso após resolução aguda

## ABORDAGEM NO PS

### PONTOS-CHAVE

- ☐ Limpeza local (irrigação sob o opérculo) é a base do tratamento
- ☐ Analgesia com AINE (ibuprofeno) para a dor
- ☐ Antibiótico apenas se houver sintomas sistêmicos (febre, trismo, linfadenopatia, disseminação)
- ☐ Avaliar sinais de alarme: trismo grave, disfagia, edema cervical (encaminhar urgente)
- ☐ Bochechos com clorexidina 0,12% como adjuvante
- ☐ Encaminhar para exodontia do siso após resolução — tratamento definitivo e prevenção

SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente de 22 anos com dor retromolar, edema do opérculo sobre o terceiro molar inferior semi-incluso, sem febre nem trismo. Qual é a conduta?

- A) Antibiótico oral por 10 dias e exodontia imediata
- B) Limpeza local (irrigação sob o opérculo) + analgesia com AINE + bochechos com clorexidina; ATB não necessário
- C) Internação para antibiótico IV
- D) Exodontia de urgência durante a fase aguda
- E) Corticoide oral isolado

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual dente é mais frequentemente associado à pericoronarite?

- A) Incisivo central superior
- B) Primeiro pré-molar
- C) Terceiro molar inferior (siso) semi-incluso
- D) Canino superior
- E) Segundo molar superior

### QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Em qual situação a antibioticoterapia está indicada na pericoronarite?

- A) Em todos os casos, sempre
- B) Apenas quando há sintomas sistêmicos (febre, trismo, linfadenopatia, disseminação)
- C) Nunca é indicada
- D) Apenas em pacientes idosos
- E) Somente após a exodontia

### QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é o tratamento DEFINITIVO da pericoronarite recorrente do terceiro molar?

- A) Antibioticoterapia contínua
- B) Exodontia do terceiro molar (após resolução do quadro agudo)
- C) Bochechos diários permanentes com clorexidina
- D) Operculectomia repetida
- E) Não há tratamento definitivo

### QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente com pericoronarite evolui com trismo grave, disfagia e edema de assoalho de boca. Qual a conduta?

- A) Manter tratamento ambulatorial com bochechos
- B) Internação + antibiótico IV + avaliação buco-maxilo + proteção de via aérea (risco de angina de Ludwig)
- C) Apenas aumentar a dose do AINE
- D) Exodontia ambulatorial imediata
- E) Alta com antibiótico oral

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Pericoronarite aguda localizada (sem sintomas sistêmicos): tratamento é limpeza local (irrigação sob o opérculo, remoção de debris) + analgesia (AINE) + bochechos com clorexidina. Antibiótico NÃO é necessário sem repercussão sistêmica. Encaminhar para exodontia após resolução.

### QUESTÃO 2 → Resposta: C

O terceiro molar inferior (siso) semi-incluído é o dente mais associado à pericoronarite. O opérculo gengival que recobre parcialmente o dente acumula placa e restos alimentares, favorecendo a inflamação/infecção. Comum em adultos jovens (17-25 anos).

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

Antibiótico na pericoronarite é indicado APENAS quando há sintomas sistêmicos (febre, trismo, linfadenopatia, disseminação). Na forma localizada, a limpeza local resolve. Amoxicilina ou metronidazol são opções. ATB nunca substitui a limpeza local e o tratamento definitivo (exodontia).

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

O tratamento definitivo da pericoronarite recorrente é a exodontia do terceiro molar, realizada após a resolução do quadro inflamatório agudo. Remove a causa (opérculo + dente semi-incluído) e previne recorrências. Operculectomia é alternativa em casos selecionados.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

Trismo grave + disfagia + edema de assoalho de boca indicam disseminação para espaços fasciais profundos, com risco de angina de Ludwig e comprometimento de via aérea. Conduta: internação, ATB IV (ampicilina-sulbactam), avaliação buco-maxilo, TC cervical e proteção de via aérea.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico